جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : حنان عبدالعاطى على احمد
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** اوسيم **العنوان :** -ش سعد زغلول/بشتيل
رقم البطاقة : 26501040100684 **رقم التليفون :** 01114647452 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 23-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 04-01-1965 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: حنان عبدالعاطي علي احمد
National ID: 26501040100684

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Bone scintigraphy**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٦٥٠١٠٤٠١٠٠٦٨٤ ٢٠٢٦/٠٦
ربة منزل
انثى مسلمة متزوجة
سلطان جمعه مرسى محمد
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠٦/٢٣

١ Dms

شهر

اشعه مقطعية بالصبغه

على المرارة والكبد

والحوض



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
حنان
عبدالعاطى على احمد
٤ش سلطان جمعه-ش سعد غلول-بشتيل
مركز أوسيم - الجيزه
٢٦٥٠١٠٤٠١٠٠٦٨٤
١٩٦٥/٠
LU6748730

National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

جوستافروسي

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

البنت المصرية هي صحة مصر

08/23/2026

MDT FORM

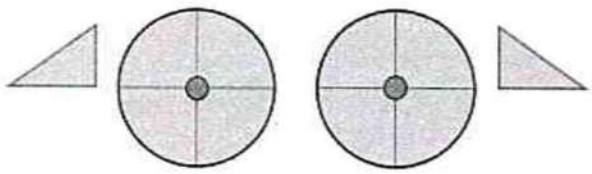
Name:	حنان عبدالعاطى على احمد	**MRN:**	12709
Age:	62 Y	**ID:**	26501040100684
Menopausal Sta	post	**Phone:**	01114647452
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	
CO Morbidity:	HTN	**Reason Of MDT:**	new

Clinical Data:

BX: IDC G II

ER: 8/8 **PR:** 8/8 **HER2:** 0 **KI67:** 10%

R L



TNM

Sonomammography:

ACR B

rt UOQ zone B-C 5.8 cm from nipple 4.9x1.8 cm

Another indistinct outlines hypoechoic area of parenchymal distortion is seen medial to the index mass by about 23 mm measures 16x7 mm. • Also UOQ axillary region irregular outlines hypoechoic mass measures 2.8 x 2.5 cm ? another mass ? infiltrated axillary lymph node with extracapsular extension .

Mets Workup:

Ct

Opinion:

? Known right breast cancer with right Axillary Lymphadenopathy. ? Fatty Hepatomegaly, rest of Abdomen & Pelvis study is Unremarkable

? Unremarkable both lung fields with No suspicious lesions.

o Noted Dorsolumbar vertebral spondylosis

History:

clinically: small breast with UOQ skin therthring + palpable anterior induration reaching the nipple + palpable large axillary LN

for possibility of NACT then rt MRM

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

porta-cath

echo

NA AC X4 TXT X4 THEN RT MRM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د محمد كيلاني	د محمد غيراوي	د فرمين رمضان			

Name: حنان عبدالعاطى على احمد	
MR. : 12709	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was diagnosed with right-sided breast cancer that is estrogen-receptor positive (8/8), progesterone-receptor positive (8/8), HER2 negative (0), and Ki-67 low (10%). Clinically, there is a small breast with upper-outer-quadrant skin tethering, a palpable anterior induration extending to the nipple, and a large palpable axillary lymph node. The treatment plan was initiated with four cycles of dose-dense Adriamycin (doxorubicin) 60 mg/m² and cyclophosphamide (Endoxan) 600 mg/m² (AC ×4), followed by four cycles of paclitaxel (TXT ×4). Baseline laboratory studies were pending at the time of planning.

The clinical pharmacy note records a serum albumin (SA) of 1.89 g/dL for cycle 1 (C1) of the AC regimen, with administered doses of Adriamycin 113 mg and Endoxan 1130 mg. The patient has therefore completed one cycle of the AC regimen.

تحريرا في ,

التاريخ :	20-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : Ali Adel

يعتمد ,

Pat. Name: Hanan Abd Alaati Ali	Pat. ID: 3584623
Procedure Name: 3D Digital Mamo with Tomo -Bo	Date: 22/06/2026

- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Preserved axillary lymph nodes.

RIGHT BREAST:

- UOQ (zone b-c about 5.8 cm from nipple) speculated outlines (having long spicules partially extending toward to the nipple) dense mass lesion is seen showing microcalcifations within .Axillary region prominent lymph nodes and speculated outlines mass also seen .
- This was confirmed by **3D Tomosynthesis 1mm section images.**
- **Complementary US** demonstrated an irregular outlines hypoechoic soft tissue mass located corresponding to the previously described mass and clinically palpable lump predominantly 8-10 O,clock measures 4.9 x1.8 cm .It shows marginal , central vascularity by color doppler study .Another indistinct outlines hypoechoic area of parenchymal distortion is seen medial to the index mass by about 23 mm measures 16x7 mm .
- Also UOQ axillary region irregular outlines hypoechoic mass measures 2.8 x 2.5 cm ? another mass ? infiltrated axillary lymph node with extracapsular extension .
- Within average skin/nipple/areolar complex.
- Pathologically enlarged axillary lymph nodes level I showing cortical thickness reaching up to 46 mm .

Best regards,
Dr Suzan Mohamed

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

NHTMRI

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومى للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

قسم الباثولوجى

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name:حنان عبدالعاطي علي احمد | Age: 61 years | Sex: female
Request type: مبادرة | Sub request type:
Hospital no: | Pathology no.:546B-2026
Department:صحه مرأه | Date of result:13/7/2026
Referred by: د/مروه حسن | Date of biopsy:29/6/2026
Nature of specimen: tru-cut biopsy | I.D. Number:26501040100634
Clinical diagnosis: right breast mass

Gross pathology :

Multiple fragmented grayish white tissue cores up to 0.5x0.4cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against ER- PR- Her2- KI67

Microscopic picture: Section examined revealed core of mammary tissue showing invasive ductal carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nest, sheets and cribriform pattern infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing moderate anaplasia and moderate tendency to from tubules with frequent mitotic figures and mild lymphocytic infiltrate. There is no ductal carcinoma insitu is seen. No peri tumoral lymphovasculr emboli or perineural infiltration in core tissue examined.

Immunohistochemical Result

P63: Lost in invasive component.
ER: Strong Positive nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).
PR: Strong Positive nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).
Her2: No membranous staining in tumor cells (score0) Negative.
Ki67: Positive nuclear staining of 10% of tumor cells.

Diagnosis: Right breast mass, tru-cut biopsy:

Invasive duct carcinoma (NST), Grade II.

Signature:
Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager
BASMA REFAAT M.D

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient's Name:	**Hanan Abdel-Aty Ali Ahmed**
Date:	**2026-08-13**
Referred by:	Prof.Dr. **no doctor**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

MULTISCLICE POST CONTRAST CT EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

I- CHEST:

- **Known case of right breast cancer with skin thickening & edema beneath it a right breast mass lesion (4.1x2.0cm) with right axillary enlarged rounded lymphnodes with the largest measuring (1.8x1.3cm)**
- **Clear both lung fields with No visualized nodules or consolidation or collapse.**
- **No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.**
- **No pleural or pericardial collection.**
- **Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.**
- **Noted dorsal spine vertebral spondylosis.**

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- **Mildly enlarged liver showing homogenous parenchymal yet rather with diffuse low attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.**
- **Both kidneys are normal site, average size, and showing a smooth, regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.**
- **Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta, and IVC.**
- **Normal CT appearance of pelvic organs with no pelvic masses or collections**
- **The urinary bladder shows no evidence of gross masses, diverticulae, or stones.**
- **No abdominal or pelvic lymphadenopathy.**
- **No ascites.**
- **Noted Lumbar vertebral spondylosis.**

Opinion:

- **Known right breast cancer with right Axillary Lymphadenopathy.**
- **Fatty Hepatomegaly, rest of Abdomen & Pelvis study is Unremarkable**
- **Unremarkable both lung fields with No suspicious lesions.**
- **Noted Dorsolumbar vertebral spondylosis**

Best regards,

Dr. Ayman Shawky , FEBR

Dr Ayman Shawky

مبـــادرة رئيس الجمهورية
لدعـم صحة المرأة المصرية

08/23/2026

MDT FORM

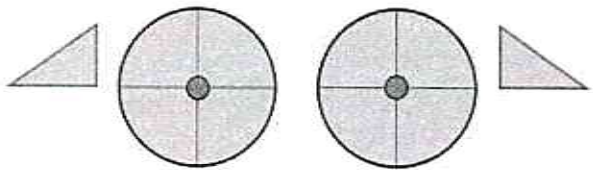
Name:	حنان عبدالعاطى على احمد	**MRN:**	12709
Age:	62 Y	**ID:**	26501040100684
Menopausal Sta	post	**Phone:**	01114647452
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	
CO Morbidity:	HTN	**Reason Of MDT:**	new

Clinical Data:

BX: IDC G II

ER: 8/8 **PR:** 8/8 **HER2:** 0 **KI67:** 10%

R L



TNM

Sonomammography:

ACR B
rt UOQ zone B-C 5.8 cm from nipple 4.9x1.8 cm
Another indistinct outlines hypoechoic area of parenchymal distortion is seen medial to the index mass by about 23 mm measures 16x7 mm. • Also UOQ axillary region irregular outlines hypoechoic mass measures 2.8 x 2.5 cm ? another mass ? infiltrated axillary lymph node with extracapsular extension .

Mets Workup:

Ct
Opinion:
? Known right breast cancer with right Axillary Lymphadenopathy. ? Fatty Hepatomegaly, rest of Abdomen & Pelvis study is Unremarkable
? Unremarkable both lung fields with No suspicious lesions.
o Noted Dorsolumbar vertebral spondylosis

History:

clinically: small breast with UOQ skin therthring + palpable anterior induration reaching the nipple + palpable large axillary LN

for possibility of NACT then rt MRM

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

porta-cath
echo
NA AC X4 TXT X4 THEN RT MRM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د محمد كيلاني	د محمد شيراوي	د نرمين رمضان			